# Árbol de decisión — Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Hombro. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 5ab4de71

**REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.**

*Desvío desde el paso 2 si «SÍ»*

**2b** La movilidad pasiva GH (sobre todo la RE) está limitada igual que la activa. ¿Hubo traumatismo previo? 📝 G2 · R3

- SÍ → 11 Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)
- NO → 10 Artrosis Glenohumeral
- NO → 1 Capsulitis Adhesiva

SÍ

**1** ¿El dolor se reproduce con movimientos cervicales, compresión axial o palpación de la primera costilla? 📝 R3, R4

todas

**2** ¿Existe una restricción GLOBAL de la movilidad pasiva, especialmente en rotación externa? 📝 R1, R2, R9

NO

**3** ¿El dolor está localizado en la parte superior (AC) o hubo un evento traumático con sensación de inestabilidad? 📝 R1, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R13

| | | |
|---|---|---|
| **SÍ** Reproducción con movimientos cervicales (test de Spurling o similar) | → | 6 Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro |
| **SÍ** Restricción de movilidad en 1ª costilla y dolor en zona de transición | → | 9 Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica) |
| **NO** No se reproduce con cervical ni 1ª costilla | → | sin hipótesis |

| | | |
|---|---|---|
| **SÍ** Restricción global de la movilidad pasiva, con pérdida marcada de rotación externa | → | → desvío 2b |
| **NO** Movilidad pasiva mayormente preservada | → | sin hipótesis |

| | | |
|---|---|---|
| Dolor en articulación acromioclavicular (parte superior) | → | 7 Artropatía Acromioclavicular |
| Evento traumático / "Pop" con sensación de inestabilidad anterior | → | 4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior) |
| Evento traumático / dolor profundo, síntomas de labrum (chasquidos) | → | 5 Lesión Labral Superior (SLAP) |
| Episodio concreto o aprensión (inestabilidad anterior o posterior, también sin «pop» traumático) | → | 4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior) |
| Ninguno de los anteriores | → | sin hipótesis |

Todas → sigue en el paso 4 ↓

↓ Paso 4: viene del paso 3

**4** ¿Hay dolor durante la elevación y/o déficits de fuerza? 📝 R1, R3, R10, R12

todas

**5** ¿Se observa asimetría o "winging" escapular durante el movimiento activo?

| | | |
|---|---|---|
| Dolor al elevar el brazo o con los test resistidos, sin debilidad marcada ni signos de déficit | → | 2 Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement) |
| Debilidad evidente caída del brazo (drop arm) o signos de déficit (lag signs) | → | 3 Rotura del Manguito Rotador |
| Sin dolor claro ni debilidad en elevación | → | sin hipótesis |

| | | |
|---|---|---|
| **SÍ** Asimetría visual en la elevación o test de asistencia escapular positivo | → | 8 Discinesia Escapular |
| **NO** Sin alteración escapular evidente | → | sin hipótesis |

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

**Sin ninguna hipótesis al final:** dolor de hombro inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 3/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0